PROTOCOLLO 3

Esame dei movimenti mandibolari secondo DC/TMD

Misurare apertura, lateralità e protrusione con metodo standardizzato

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Prima seduta e rivalutazioni	Tutti i quadri	10 minuti	Valutazione iniziale e ogni 4 sedute

Indicazioni

- ✓ Valutazione iniziale
- ✓ Monitoraggio dei progressi
- ✓ Confronto prima e dopo una tecnica

Controindicazioni e precauzioni

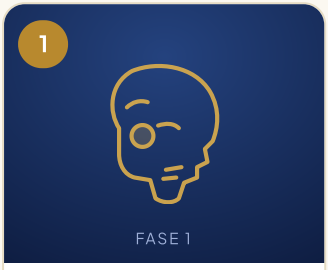
- ! Calo di peso, febbre o tumefazione non spiegati
- ! Deficit neurologici o parestesie del volto
- ! Trisma progressivo o storia oncologica del distretto testa collo
- ! Dolore che non varia con la funzione mandibolare

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: di fronte al paziente con calibro o righello millimetrato.

Esecuzione passo dopo passo



Apertura senza dolore

Il paziente apre fino al primo dolore: misura la distanza interincisale.



Apertura massima attiva

Apertura massima anche con dolore: misura e chiedi la sede del dolore.



Apertura passiva

Con delicatezza aumenta l'apertura: misura e valuta la sensazione di fine corsa.



Lateralità e protrusione

Misura le escursioni destra, sinistra e in avanti.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Valori di riferimento	apertura massima superiore a 40 mm
Strumento	calibro o righello
Registrazione	aggiungere l'overbite verticale

Criteri di rivalutazione

DIAGNOSI DC/TMD	LIVELLO DI DOLORE	IMPATTO PSICOSOCIALE
_____	____ / 10	Basso / Alto
asse I	attuale e medio	asse II

Punti chiave

- ✓ Usa sempre la stessa procedura per confronti affidabili
- ✓ Chiedi se il dolore è familiare
- ✓ Annota la deviazione o la deflessione

Errori da evitare

- ! Non sommare l'overbite alla misura
- ! Forzare l'apertura passiva
- ! Misurare con il paziente in tensione

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automisurazione	Misurare l'apertura con tre dita sovrapposte davanti allo specchio	1 volta al giorno

! **Nota clinica.** La differenza tra apertura attiva e passiva aiuta a distinguere una limitazione muscolare da una articolare.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Ohrbach R., Dworkin S.F. The evolution of TMD diagnosis: past, present, future. J Dent Res. 2016;95(10):1093–1101.